

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Ovarian Cystectomy/Oophorectomy

استئصال كيس المبيض / استئصال المبيض

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

☐ Laparotomy _____

☐ Laparoscopy _____

☐ Removal of ovary (include side) _____

C. Risks of an ovarian cystectomy/oophorectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death: 3-8 in 100,000 women (very rare as a result of complication).*

Specific risks:

- Severe bleeding, a blood transfusion may be required to replace blood loss.
- Infection in the operation site or pelvis or urinary tract. Treatment may be wound dressings and/ or antibiotics.
- Injury to other organs (*approximately 2 in 1,000*) such as the ureter(s) (tube leading from kidney to bladder) bladder or bowel. This is an uncommon risk. Further surgery will be needed to repair the injuries. For bladder injuries, a catheter (plastic tube) may be put into the bladder to drain the urine away until the bladder is healed. For ureteric injury, a plastic tube (stent) is placed in the ureter for 6 weeks and then removed by cystoscopy. If the bowel is injured it will be treated by specialized surgeon.
- Shoulder-tip pain.
- A hernia i.e. rupture can form in the long term. This may need repair by further surgery. (*less than 1 in 100*)

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يوجد مترجم ؟

☐ نعم ☐ لا
☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريضة)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

☐ فتح البطن _____

☐ منظار البطن _____

☐ استئصال المبيض (حدد الجهة) _____

ج. مخاطر استئصال كيس المبيض / استئصال المبيض

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات تشمل ولكنها لا تقتصر على ما يلي:

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين أو كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة: 3-8 في 100,000 مريضة (ينذر جداً أن تحدث نتيجة للمضاعفات).

مخاطر محددة:

- حدوث نزيف شديد وقد تكون هناك حاجة لنقل الدم لتعويض الفاقد منه.
- عدوى في موضع العملية أو الحوض أو الجهاز البولي وقد يكون العلاج بتضميد الجرح و/أو المضادات الحيوية.
- قد تحدث إصابة لأعضاء أخرى (حوالي 2 في 1,000) كالحالب أو الحالبين (الأنابيب الواصلة بين الكلى والمثانة البولية) أو للمثانة البولية أو الأمعاء وهذا الخطر غير شائع. تكون هناك حاجة لإجراء جراحات أخرى لإصلاح هذه الإصابات. ولإصابات المثانة البولية قد توضع قسطرة (أنبوب بلاستيكي) داخل المثانة لتصريف البول لحين اكتمال التئام المثانة. ولإصابات الحالب يتم إدخال أنبوب بلستيكي (دعامة) في الحالب لسدة أسابيع ثم تتم إزالتها بمنظار المثانة البولية. وإن حدثت إصابة للأمعاء فسيتم إزالة الجزء المصاب من الأمعاء مع احتمال عمل فتحة مؤقتة أو دائمة في القولون (فغر القولون). وإذا كانت الإصابة في الكلية فقد يتم استئصالها. وإذا أصيبت الأمعاء فسيقوم جراح متخصص بمعالجتها.
- ألم في طرف الكتف.
- قد يحدث فتق (تمزق) في المدى الطويل مما قد يتطلب إصلاح بإجراء

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Wound may heal normally with a thickened scar which may be red. This is called a “keloid”.
- Occurrence of other cysts, which may need future surgery.
- Adhesions to site of cyst removal.
- If both ovaries are removed before onset of menopause, risk of osteoporosis and may require therapy e.g. hormone therapy.
- Need for oophorectomy when consented for a cystectomy if bleeding excessive or ovary badly damaged.
- *Need for laparotomy when consented for a laparoscopy in case of failure to gain entry to the abdominal cavity and to complete the intended procedure or there are complications like excessive bleeding.*

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.

- جراحة أخرى. (أقل من 1 في 100).
- قد يلتئم الجرح بطريقة طبيعية وقد تزداد سماكة الندبة الجراحية ويصبح لونها أحمر وتكون مؤلمة (تكون ندبة الجذرة) وهي تليف للجلد يعقب الجروح) وقد تكون دائمة وقد تسبب تشوه.
- ظهور أكياس أخرى مما قد يتطلب جراحة أخرى.
- التصاقات في الموضع التي تمت فيه إزالة كيس المبيض.
- إذا تم استئصال كلا المبيضين قبل وصول المريضة لسن توقف الطمث يكون هناك خطر الإصابة بهشاشة العظام وقد يتطلب معالجة كالعلاج الهرموني مثلاً.
- بالرغم من توقيع المريضة على إقرار الخضوع لإجراء استئصال كيس المبيض فقط ، إلا أنه قد تظهر حاجة لاستئصال كامل المبيض إذا كان هناك نزيف مفرط أو كان المبيض متضرراً بشدة.
- هناك ضرورة لفتح البطن على الرغم من توقيع المريضة على إقرار الخضوع لإجراء منظار للبطن وذلك في حالة تعذر الوصول للتجويف البطني لإكمال الإجراء المطلوب أو وجود مضاعفات مثل نزيف شديد.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ويكمل ذلك في سجل المريضة الطبي إذا اقتضى الأمر.)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل ذلك في سجل المريضة الطبي إذا اقتضى الأمر.)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتوثيق نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريضة)

ز . إقرار المريضة

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية / العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure *(under the supervision of the treating consultant)*. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
- ☐ Ovarian Cystectomy / Oophorectomy
- ☐ Blood & Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,
I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

- المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم برعاية مهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء على نقل دم لي.
- احتمال إزالة أنسجة أو دم وقد يتم استخدامها في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث ما يهدد حياتي أثناء الإجراء (لا سمح الله) فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري (تحت إشراف الاستشاري المعالج) وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ استئصال كيس المبيض / استئصال المبيض
- ☐ نقل الدم أو مشتقاته لي
- منحني طبيبي الفرصة لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي واهتماماتي فيما يتعلق بحالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره والخيارات المتاحة لعلاجي وقد تم الرد على استفساراتي واهتماماتي بصورة مرضية لي.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى بعد توقيع لي لهذا النموذج ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء و كجزء منه أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو متعلقة بالمرض وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني
أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريضة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى غير المؤهلين لاتخاذ قرار بشأن الإقرار

يتم الحصول على الإقرار ممن ينوب أو ينوبون عنه في اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب أو ينوبون عن المريضة في اتخاذ القرار

الاسم:

التوقيع:

صلة القرابة بالمريضة:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/designee

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2)) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح . إفادة الطبيب أو من ينوب عنه
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ،
وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب أو من ينوب عنه:

اللقب:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

اسم الشاهد (على هذا التوقيع أعلاه)

1) الاسم : _____ التوقيع : _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

2) الاسم : _____ التوقيع : _____

التاريخ: _____ الوقت: _____